Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de São Pedro do Sul

Rua Ernesto Wagner, 233, 2º andar - Bairro: Centro - CEP: 97400000 - Fone: (55) 3029-9990 - Balcão Virtual: (55)9.9911-7542 - Email: frsaopedrovjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001006-59.2024.8.21.0129/RS

AUTOR: LIZIANI VARGAS DA SILVA

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

I - Relatório

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por **LIZIANI VARGAS DA SILVA** em desfavor do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPERGS**, ambos qualificados.

Narrou, em síntese, que é portadora da Neoplasia Maligna do Rim (CID 10 C64), razão pela qual precisa usar os medicamentos Nivolumabe (Opdivo®), por via endovenosa, 192mg a cada 21 dias, durante 4 ciclos e Ipilimumabe (Yervoy®), também aplicado por via endovenosa, 64mg a cada 21 dias, durante 4 ciclos. Referiu que após, a partir do 5º ciclo, iniciaria a fase de manutenção, onde seria administrado somente o medicamento Nivolumabe (Opdivo®), 480 mg, por via endovenosa, a cada 28 dias, por prazo indeterminado. Referiu que os medicamentos não podem ser substituído por outros medicamentos e não são disponibilizados pelo réu. Liminarmente, requereu o fornecimento pelo réu dos fármacos, sob pena de bloqueio de valores. No mérito, pugnou confirmação dos efeitos da tutela antecipada, com a condenação do réu ao fornecimento dos medicamentos postulados. Postulou a concessão da AJG. Juntou documentos (evento 1, INIC1).

Recebida a inicial, foi concedida a AJG e deferida a tutela de urgência, determinando-se a citação/intimação do réu (evento 4, DESPADEC1).

Citado, o réu contestou a ação (evento 22, CONT1). Preliminarmente, requereu a retificação do polo passivo da demanda, com a substituição do IPERGS pelo IPÊ-SAÚDE.

No mérito, referiu que a parte autora não faz jus ao tratamento postulado na inicial, diante da ausência de cobertura contratual. Afirmou que o tratamento não está previsto no protocolo oncológico adotado pelo ente. Disse que existem alternativas ao tratamento postulado, o qual careceria de comprovação quanto à eficácia. Pugnou pela improcedência da demanda. Juntou documentos.

Houve réplica (evento 26, RÉPLICA1).

Intimadas para manifestarem-se acerca da pretensão probatória (evento 27, ATOORD1), as partes nada postularam (evento 34, PET1, e evento 35, PET1).

O Ministério Público declinou da possibilidade de intervir no feito (evento 32, PROM1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

II - Fundamentação

Em tempo, diante da justificativa apresentada pelo requerido e do entendimento jurisprudencial, desde já, promovi a retificação do polo passivo da demanda, com a substituição do IPERGS pelo IPÊ-SAÚDE, conforme postulado pelo réu em sede de contestação.

No mais, considerando a inexistência de nulidades a serem sanadas e/ou preliminares pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, consigno que a qualidade de segurada da demandante é incontroversa, de modo que a controvérsia cinge-se quanto à negativa exarada pelo réu em relação ao tratamento médico requerido pela parte autora.

Da análise do procedimento administrativo conduzido pela autarquia (evento 1, CERTNEG10), constata-se que a negativa se deu pelo entendimento de que os medicamentos postulados não estão previstos nas diretrizes de cobertura de tratamento oncológico.

Com efeito, o artigo 4º da Lei Complementar Estadual nº 15.145/2018, que dispõe sobre o IPE-SAÚDE e dá outras providências, estabelece que integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde previstos em tabelas próprias, excluindo-se procedimentos, exames, tratamentos, insumos e materiais nela não previstos.

Outrossim, estatui o art. 8º da Resolução nº 21, que regulamenta a Assistência Médico-Hospitalar do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, que se incluem no plano de assistência médica as seguintes especialidades: *anestesiologia, angiologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geral, ginecologia, hematologia e hemoterapia, imunologia (alergia), medicina nuclear, nefrologia, obstetrícia, oftalmologia, oncologia, otorrinolaringologia, patologia clínica e cirurgia, pediatria, plástica reparadora, proctologia, psiquiatria, radiologia, radioterapia, reumatologia, tisiopneomologia, torácica, traumatologia e urologia.*

Diante dessas disposições legais, é claro o direito da parte autora, enquanto beneficiária, postular do IPERGS, autarquia do Estado responsável pelo sistema de saúde e previdência, o fornecimento do medicamento, necessário ao tratamento de sua patologia.

É descabida a alegação do demandado de que o fornecimento do fármaco postulado deveria ser negado por não estar previsto dentre as diretrizes internas para tratamento oncológico.

Assim, é forçoso reconhecer que a parte autora faz jus ao tratamento postulado na inicial, porque voltado ao combate de moléstia que se inclui âmbito das especialidades abrangidas pelo plano de saúde.

Ademais, a escolha do tratamento a ser utilizado cabe ao médico, e não ao convênio ou ao paciente, uma vez que a opção pela medida terapêutica adequada pressupõe a análise individual da evolução da doença e do quadro clínico apresentado, de sorte que somente o profissional especializado – nesse caso, o médico –, é quem poderá optar e recomendar o melhor método a ser utilizado.

No caso concreto, o médico assistente justificado plenamente a opção pelo medicamento postulado, uma vez que já utilizadas outras medicações sem efeito satisfatório ao controle da patologia que acomete a autora (evento 1, LAUDO8):

PACIENTE

LIZIANI VARGAS DA SILVA CPF: 002.144.140-51

Atestado Médico

RELATÓRIO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que a paciente Liziani Vargas da Silva, 46 anos, é portadora da patologia de CID 10: C.64, quadro avançado/metastático para figado e ossos desde o diagnóstico em 24/05/2024. Por se tratar de uma doença de Alto Risco conforme critérios do IMDC e também por apresentar grande volume de doença metastática, indico o tratamento paliativo, INICIALMENTE COM O TRATAMENTO DE INDUÇÃO com os medicamentos 1) Nivolumabe (Opdivo) -- Aplicar por via endovenosa 192 mg a cada 21/21 dias durante 4 ciclos + 2) Ipilimumabe (Yervoy) - Aplicar por via endovenosa 64 mg a cada 21/21 dias durante 4 ciclos. Após o término do tratamento de Indução, deverá iniciar o TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO com 3) Nivolumabe (Opdivo) -- Aplicar 480 mg por via endovenosa a cada 28/28 dias, por prazo indeterminado (enquanto estiver respondendo ao tratamento, estiver sem progressão e sem toxicidade limitante), sendo assim, no mínimo por um periodo de 12 meses (NÃO AUTORIZADOS PELO IPERGS E NÃO DISPONÍVEIS NO SUS).

Assim sendo, solicito as medicações acima, baseado nos estudos clínicos abaixo, onde seu não uso pode implicar em progressão da doença de base, piora clínica e da qualidade de vida e até mesmo risco de óbito.
Tal indicação é baseada e respaldada conforme os estudos clínicos abaixo, melhorando a taxa de resposta, a sobrevida livre de progressão e sobrevida global:

1) Nivolumab plus Ipilimumab versus Sunitinib in Advanced Renal-Cell Carcinoma: R.J. Motzer, N.M. Tannir: N Engl J Med 2018;378:1277-90. DOI: 10.1056/NEJMoa1712126

2) Tannir NM, Frontera OA, Hammers HJ: Thirty-month follow-up of the phase III CheckMate 214 trial of first-line nivolumab + ipilimumab (N+I) or sunitinib (S) in patients (pts) with advanced renal cell carcinoma (aRCC). J Clin Oncol. 2019 Feb 26;37 (7_suppl): 547-547.

A paciente encontra-se em performance status 1 (um), de intercorrências evoluiu com uma fratura patológica em membro inferior direito, necessitando de intervenção cirúrgica, sem demais comorbidades.

Grato!!

28 de Maio de 2024

Nesse contexto, diante da imprescindibilidade de uso dos medicamentos, os quais estão devidamente registrados na ANVISA, e da ineficiência do tratamento com outros fármacos, há de se reconhecer a prevalência do direito constitucional à saúde sobre as alegadas limitações administrativas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPE-SAÚDE. MEDICAMENTO: STELARA (USTEQUINUMABE). APLICABILIDADE DA LEI Nº 15.145/18. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. - O art. 4º da Lei Complementar nº 15.145/18, que revogou a Lei nº 12.134/04, dispõe que integram o plano de saúde atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos, exceto os tratamentos não previstos nas tabelas do próprio Instituto (§1º). Ocorre que o entendimento jurisprudencial do STJ e deste TJRS é claro no sentido de que o plano de saúde não pode selecionar o tipo de tratamento dispensado ao segurado HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A CONTAR O TRÂNSITO EM JULGADO. ÍNDICE HÍBRIDO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. - A partir de dezembro de 2021, quando promulgada a EC nº 113/2021, aplica-se a todos os débitos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual, "por constituir índice híbrido que contempla a defasagem inflacionária e os juros reais", não pode ser cumulado com nenhum outro indexador para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50008834120218210105, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 15-06-2023)

*APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO. SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. IPÊ-SAÚDE. LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. IBRUTINIBE (IMBRUVICA®). NEGATIVA DO IPERGS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. A LEI COMPLEMENTAR Nº 15.145/2018, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE SAÚDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (IPE-SAÚDE), PREVÊ A COBERTURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, ASSIM COMO OS ATOS NECESSÁRIOS AO DIAGNÓSTICO E AO TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE QUE PADECE O SEGURADO. A FALTA DE CONTEMPLAÇÃO, PELO PROTOCOLO DO IPERGS, DO **MEDICAMENTO** INDICADO NÃO HÁ DE PREVALECER QUANDO DEFINIDO PELO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO QUE ASSISTE À PARTE COMO SENDO O ADEQUADO PARA O TRATAMENTO DE QUE CARECE. PROTOCOLO ONCOLÓGICO APLICADO PELA AUTARQUIA QUE SE REPORTA AO JÁ DISTANTE ANO DE 2010,*

CONSIDERANDO-SE OS PERMANENTES AVANÇOS NA MEDICINA E A EVOLUÇÃO DE TRATAMENTOS, AINDA MAIS NESSA ÁREA ESPECÍFICA, A ONCOLOGIA, COMO É PÚBLICO E NOTÓRIO. MANTIDOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.(Apelação Cível, Nº 50798667520218210001, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 09-08-2022);

Deste modo, a procedência da demanda é a medida que se impõe.

III - Dispositivo

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc., do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **LIZIANI VARGAS DA SILVA** contra o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS** para, tornando definitivos os efeitos da tutela de urgência deferida (evento 4, DESPADEC1) para **DETERMINAR** que o réu providencie o fornecimento, em favor da parte autora, dos medicamentos **Nivolumabe (Opdivo®)**, por via endovenosa, 192mg a cada 21 dias, durante 4 ciclos e **Ipilimumabe (Yervoy®)**, por via endovenosa, 64mg a cada 21 dias, durante 4 ciclos, bem como, a partir do 5º ciclo, exclusivamente o medicamento Nivolumabe (Opdivo®), 480 mg, por prazo indeterminado.

Sucumbente, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais em favor do procurador da parte adversa, os quais fixo em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

De outra banda, deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de Taxa Única, eis que isenta, sendo devidas, tão somente, despesas, a teor do que prevê a Lei da Taxa Única e a Recomendação 04/2020-CGJ.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Agendada intimação via eproc.

Documento assinado eletronicamente por **WALKYRIA MARIA ALVARES DOS PRAZERES C DE S C, Juíza de Direito**, em 24/04/2025, às 14:56:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10081174817v4** e o código CRC **aa524453**.